EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS N° EGRESO : 90469
SERVICIO : MEDICINA HSC
FECHA : 2024-08-12 11:16:00

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: HECTOR RUBEN MENDEZ FUENTES			RUN	: 7.396.411-3
F.Nac	: 18-02-1955	Edad	: 69 AÑOS, 5 MESES	Género	: Masculino
Dirección	: CHACAY			Comuna	: NIQUEN
Previsión	: FONASA B	Teléfono	: 942304849		
Fecha Ingreso	: 2024-07-21	Fecha Egreso	: 2024-08-12 11:16:00	Causal	: MEDICA
Condición	: VIVO	Destino	: DOMICILIO	Derivación	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. I64-ACCIDENTE VASCULAR ENCEFALICO AGUDO, NO ESP.COMO HEMORRAGICO

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

1. ACV isquémico fronto-opercular-insular-temporal derecho, c/TH PH-1, trombolizado y trombectomizado +- Oclusión M1 distal derecha (20.07.24)
- Disfagia leve
- Sd comicial 2rio
2. FA paroxística sin TACO
3. LCFA (asma sin tto) sobreinfectado, ATB 7/7
4. Edema aritenoideo recuperado
5. Conjuntivitis bacteriana resuelta
6. Baja visión severa bilateral (retinopatía diabética)
7. HTA / DM2 IR

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. I64.X-ACCIDENTE VASCULAR ENCEFALICO AGUDO NO ESPECIF.COMO HEMORRAG (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)
2. J00-J06-INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)
3. I10-HIPERTENSION ESENCIAL(PRIMARIA) (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)
4. E10-DIABETES MELLITUS INSULINODEPENDIENTE (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)
5. I48.0-FIBRILACION AURICULAR PAROXISTICA (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)
6. J04-LARINGITIS Y TRAQUEITIS AGUDAS (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

mRS 2, vive con hija, con antecedentes descritos, con limitación de funcionalidad por severa reducción AV bilateral, consulta en urgencias el 20.07.24 en HSC por déficit neurológico de 20 min evolución presenciado por hija, caracterizado por desorietanción, dificultad para hablar, movilizar hemicuerpo izquierdo asociado de pérdida control esfinter urinario, PA S 170. HGT 327, sin conflicto ventilatorio, afebril, evaluado por Teleneurología, NIHSS 14, TC cerebro con stop M2 derecha, se indica trombolisis endovenosa con TNK y se deriva para trombectomía en H. Regional Concepción, realizándose sin incidentes, a su retorno en UTI paciente cursa con FA paroxística, se mantiene con evolución clínica favorable, presenta durante primeros días tos con expectoración abundante, se inicia ATB primera línea sin respuesta favorable, se ajusta a Ampicilina-sulbactam con respuesta clínica y de laboratorio favorable (CSB negativo), además con disfagia severa, evaluado (2) por OTRL quien diagnóstica edema aritenoideo severo y signos de RGE, que mejora significativamente con corticoides ev+ omeprazol, mejorando además disfagia, se indica retiro SNG hace 5 días, con deglución sin incidentes. Al examen neurológico actual, paciente vigil, orientado TE parcialmente, atento, comprende órdenes, sin disartria ni afasia, amaurosis bilateral, PFC leve izquierda, M3 Braquial izquierdo (M3- distal), M4+ crural izquierdo, hipoestesia leve FBC izquierda.
Se realiza TC cerebro 11.08.24, sin nuevas lesiones, hipodensidad secuelar fronto-insular derecha con signos de hematoma ph1 en reabsorción, sin sangrados agudos. Por este motivo, se indicará de forma ambulatoria inicio de anticoagulación (evaluar en control post- alta, 1 mes tras ACV). Indico por evolución clínica favorable.

INDICACIONES AL ALTA

1. REPOSO RELATIVO, MOTIVAR MOVILIZACIÓN PASIVA
2. REGIMEN SEGUN INDICACION POR FONOAUDIOLOGIA DIABETICO+ HIPOSODICO
3. AMLODIPINO 10 MG VO DIA
4. LOSARTAN 50 MG VO C/12 HRS
5. OMEPRAZOL 20 MG VO DIA
6. LEVETIRACETAM 500 MG VO C/12 HRS
7. SERTRALINA 50 MG VO DIA AM
8. QUETIAPINA 25 MG 1/2 SOLO SI TRASTORNO DEL SUEÑO
9. INSULINA NPH 10 U SC DIA AM
10. ATORVASTATINA 40 MG VO DIA
11. BISOPROLOL 2,5 MG VO DIA
12. EVALUAR EN CONTROL POST ALTA POR NEUROLOGIA FECHA INICIO DE ANTICOAGULACIÓN (ULTIMA CREA 0,9)
13. IC KINESIOLOGIA + FONOAUDIOLOGIA + TO AMBULATORIA
14. CONTROL POR NEUROLOGIA POST ALTA

EXÁMENES Y RESULTADOS

12.08.24: CREA 0,9, PCR 16,4, UREMIA 30, NA+ 138, K+ 4,6, CL- 106, LEUCOCITOS 7900, PLAQEUTAS 304.000, HTO 33,2%
11.08.24 TC CEREBRO YA DESCRITO + TC TORAX SIMPLE SIN ALTERACIONES AGUDAS
08.08.24: CREA 0,9, pcr MENOR 5, bun 19, UREMIA 41, nA+ 139, k+ 4,3, cL- 104
01.08.24: CREA 0,8, pcr 28,3, bun 21, UREMIA 46, nA+ 148, k+ 4,1, cL- 102, HTO 38,7%, LEUCOCITOS 8700, PLAQUETAS 534.000, H. GLICOSILADA 8%
31.07.24: COL TOTAL 83,HDL32,LDL 37, TG 71, PCR 65,2, LEUCOCITOS 8500, HTO 31,7, PLAQUETAS 425.000, TSH 0,2, T4L 0,8, VIT B12 1431
30.07.24: CREA 1,0, pcr 147,6, UREMIA 80, Na+ 149, K+ ,6, Cl- 111, leucocitos 16.300, plaquetas 423.000, hto 33%, procal 0,4
29/7/24

Control en: 10 días en HOSPITAL DE SAN CARLOS

NATALIA BEATRIZ HERNANDEZ LAGOS
MEDICO TRATANTE
15877858-0

JEFE SERVICIO